Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

BLOK REPRODUKSI · PROGRAM S1 KEDOKTERAN

Sifilis dalam Kehamilan

Skrining, alur tata laksana nasional, dan pencegahan sifilis kongenital

Dr. dr. Deviana Soraya Riu, Sp.OG(K)

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Setelah sesi ini, mahasiswa mampu…

3A

Tingkat kemampuan 3A

Infeksi sifilis dalam kehamilan (SNPPDI 2019): mendiagnosis, memberi terapi pendahuluan pada keadaan bukan gawat darurat, dan merujuk dengan tepat.

1. Menjelaskan patogenesis penularan transplasental dan dampaknya pada janin
2. Menentukan stadium sifilis dari anamnesis dan pemeriksaan
3. Menginterpretasi tes treponema dan nontreponema
4. Menerapkan regimen benzatin penisilin G sesuai PNPK 2026
5. Menentukan tata laksana bayi, pasangan, dan rujukan
6. Menjelaskan pencegahan melalui triple eliminasi

KASUS PEMICU

Think · Pair · Share — 5 menit

Ny. S, 22 tahun, G1P0A0, hamil 18 minggu

Kunjungan antenatal pertama (K1) di Puskesmas. Tidak ada keluhan. Suami bekerja di luar kota dan pulang tiap 2 bulan.

Tidak ada ruam, ulkus, atau pembesaran kelenjar. Tidak ada riwayat alergi obat.

Tes cepat dual HIV/sifilis: HIV non-reaktif, sifilis reaktif. RPR 1:32. HBsAg non-reaktif.

Pertanyaan pemantik

1. Stadium sifilis apa ini?
2. Obat apa, berapa dosis, dan berapa kali?
3. Apa yang perlu diwaspadai setelah suntikan pertama?
4. Apa yang dilakukan untuk suami dan bayinya kelak?

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

01

Mengapa penting?

Sifilis meningkat, dan setiap kasus sifilis kongenital dapat dicegah

EPIDEMIOLOGI

Sifilis: dunia dan Indonesia

GLOBAL

8 juta

orang dewasa 15–49 tahun tertular sifilis (2022)

50–80%

kehamilan dengan sifilis tidak diobati berakhir dengan luaran buruk

1 obat

benzatin penisilin G: satu-satunya terapi yang direkomendasikan WHO untuk ibu hamil

INDONESIA

23.347

kasus sifilis tercatat sepanjang 2024

+70%

kenaikan kasus 2018–2022 (12.484 → 20.783)

40%

ibu hamil dengan sifilis yang diobati (2022); 60% tidak

Sumber: WHO Fact sheet Syphilis, Mei 2025; Kemenkes (Kompas, 8 Mei 2023; CNN Indonesia, 16 Juni 2025)

Treponema pallidum dan jalur penularannya

Agen

Spiroketa Treponema pallidum subsp. pallidum; tidak dapat dikultur rutin, diagnosis berbasis serologi.

Penularan vertikal

Transplasental, dapat terjadi pada usia kehamilan berapa pun; jarang melalui kontak lesi saat persalinan.

Penularan horizontal

Kontak seksual dengan lesi aktif; transfusi darah (jarang).

Risiko menurut stadium

Tertinggi pada sifilis primer/sekunder yang tidak diobati pada trimester III: 60–100% (PNPK 2026). Risiko lebih rendah pada sifilis laten, tetapi tetap ada.

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; WHO 2016

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

02

Patogenesis dan manifestasi

Dari spiroketemia ibu sampai sifilis kongenital

Mengenali stadium dari gejala

Stadium	Manifestasi klinis	Perjalanan
Primer	Chancre (ulkus durum): soliter, tidak nyeri, berbatas tegas, indurasi; limfadenopati regional	Sembuh sendiri 2–8 minggu
Sekunder	Ruam makulopapular termasuk telapak tangan/kaki, kondiloma lata, lesi mukosa, demam, limfadenopati generalisata, alopesia	Sembuh sendiri 1–6 bulan
Laten	Tanpa gejala, hanya serologi reaktif (bentuk tersering yang ditemukan saat skrining ANC)	Dapat bertahan seumur hidup
Tersier	Gumma, sifilis kardiovaskular (aortitis), neurosifilis	Tahun–puluhan tahun

Neurosifilis, sifilis okular, dan otosifilis dapat muncul pada stadium mana pun.

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; Pedoman PPIA Kemenkes 2019

PATOMEKANISME

Bagaimana sifilis merusak janin

1

Spiroketemia ibu

Treponema beredar dalam darah, paling banyak pada stadium primer dan sekunder

→

2

Melewati plasenta

Infeksi plasenta: vilitis, endarteritis, plasenta membesar dan pucat

→

3

Infeksi janin

Hati, tulang, kulit, paru, dan SSP; hepatomegali, anemia, hidrops

→

4

Luaran

Abortus, lahir mati, prematur, PJT, kematian neonatal, sifilis kongenital

Benzatin penisilin melewati plasenta dan mengobati janin sekaligus. Terapi ≥ 30 hari sebelum persalinan mencegah hampir semua sifilis kongenital.

Sumber: WHO 2017; Williams Obstetrics 26th ed.; Gomez dkk., Bull WHO 2013

DAMPAK

Luaran kehamilan dan sifilis kongenital

Kehamilan dan janin

- Abortus dan lahir mati
- Persalinan preterm, BBLR, PJT
- Hidrops fetalis, asites, polihidramnion
- Plasentomegali
- Kematian neonatal

Sifilis kongenital

- Dini (< 2 tahun): hepatosplenomegali, ruam/pemfigus telapak, rinitis 'snuffles', osteokondritis, pseudoparalisis Parrot, anemia
- Lanjut (≥ 2 tahun): gigi Hutchinson, keratitis interstisial, tuli saraf, hidung pelana, tibia saber
- Sebagian besar bayi tampak normal saat lahir

Sumber: WHO Fact sheet 2025; PNPK Sifilis 2026; Gomez dkk., Bull WHO 2013

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

03

Diagnosis

Skrining semua ibu hamil, jangan tunda pengobatan

DIAGNOSIS

Skrining dan dua jenis tes serologi

Kapan skrining

- K1, sebelum 16 minggu
- Ulang awal trimester III atau 3 bulan kemudian
- Saat nifas bila belum pernah diperiksa

Tes treponema

- TP rapid, dual HIV/sifilis, TPHA, TP-PA
- Tetap reaktif seumur hidup
- Tidak membedakan infeksi aktif dan lampau

Tes nontreponema

- RPR/VDRL kuantitatif (titer)
- Menilai aktivitas dan respons terapi
- Positif palsu biologik; fenomena prozon pada kehamilan → minta pengenceran serial

Di FKTP, tes cepat dual HIV/sifilis memungkinkan diagnosis dan pengobatan pada hari yang sama. Periksa RPR kuantitatif sebagai titer awal, tetapi jangan biarkan menunggu hasil RPR menunda suntikan pertama.

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; WHO 2017

Membaca kombinasi tes treponema dan RPR

Treponema	RPR	Riwayat	Interpretasi	Tindakan
NR	NR	—	**Tidak ada sifilis (atau sangat dini)**	Ulang awal trimester III
R	R	Belum pernah diobati	**Sifilis aktif**	Obati sesuai stadium, obati pasangan
R	NR	Belum pernah diobati	**Sifilis laten lama atau sangat dini**	Pada ibu hamil: obati sebagai laten
R	R/NR	Diobati adekuat, titer turun ≥ 4×	**Respons terapi atau serofast**	Tidak perlu terapi ulang; pantau titer
R	R	Titer naik ≥ 4× dari sebelumnya	**Reinfeksi atau gagal terapi**	Obati ulang; periksa pasangan
NR	R	—	**Kemungkinan positif palsu**	Konfirmasi TPHA/TP-PA

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; Pedoman PPIA Kemenkes 2019

AKTIVITAS

Diskusi kelompok — 7 menit

Tentukan stadium dan regimennya

Empat ibu hamil dengan tes treponema dan RPR reaktif. Stadium apa, dan berapa dosis benzatin penisilin?

Ibu A

Ulkus tidak nyeri, keras, di labia mayora sejak 2 minggu; kelenjar inguinal membesar

Ibu B

Ruam merah tidak gatal di telapak tangan dan kaki, plak basah di perineum

Ibu C

Tanpa keluhan; skrining K1 reaktif, RPR 1:16, tidak tahu kapan tertular

Ibu D

Tanpa keluhan; RPR 1:2; pernah disuntik penisilin 3× tahun lalu, titer saat itu 1:64

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

04

Alur Tata Laksana Nasional

PNPK Tata Laksana Sifilis — KMK
HK.01.07/MENKES/291/2026

Ibu hamil dengan tes sifilis reaktif

Skrining K1 (< 16 mgg): tes cepat dual HIV/sifilis

NON-REAKTIF

Ulang awal trimester III atau 3 bulan kemudian

REAKTIF → RPR kuantitatif, tentukan stadium, tanya alergi

Alergi penisilin → rujuk untuk desensitisasi

PRIMER / SEKUNDER

Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM, 2 dosis selang 1 minggu

LATEN (TANPA GEJALA)

BP 2,4 juta IU IM tiap minggu × 3 (hari 1, 8, 15; jarak ≤ 9 hari)

SETELAH TERAPI

Waspada reaksi Jarisch-Herxheimer

Obati pasangan

USG janin > 20 minggu

RPR ulang; bayi dievaluasi saat lahir

Jangan tunda: dosis pertama diberikan pada hari diagnosis

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; WHO 2017

Benzatin penisilin G dan alternatifnya

Stadium	Lini pertama (PNPK 2026)	Alternatif
Primer / sekunder	**BP 2,4 juta IU IM, dosis kedua 1 minggu kemudian**	Prokain penisilin G 1,2 juta IU IM/hari × 10 hari, atau seftriakson 1 g IM/IV/hari × 10 hari
Laten	**BP 2,4 juta IU IM/minggu × 3 (hari 1, 8, 15); jarak ≤ 9 hari**	Prokain penisilin G 1,2 juta IU IM/hari × 20 hari
Alergi penisilin	**Desensitisasi di RS, lalu BP (rekomendasi 1C)**	Eritromisin 4 × 500 mg: 14 hari (dini) / 30 hari (laten)

Eritromisin mengobati ibu tetapi TIDAK melewati plasenta: janin tidak terobati, sehingga bayi harus diobati segera setelah lahir. Doksisiklin dikontraindikasikan pada kehamilan.

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026; WHO 2016

APA YANG BERUBAH?

Pedoman PPIA 2019 dan PNPK Sifilis 2026

Sebelumnya

- Sifilis dini: BP 2,4 juta IU dosis tunggal
- Alergi penisilin: eritromisin sebagai pilihan utama
- Tidak ada batas jarak dosis khusus ibu hamil

PNPK 2026

- Ibu hamil sifilis primer/sekunder: tambah dosis kedua 1 minggu kemudian
- Laten: 3 dosis, jarak tidak boleh > 9 hari
- Alergi: desensitisasi diutamakan; seftriakson/prokain bila BP tidak tersedia
- Skrining ulang awal trimester III

Mengapa? Kegagalan terapi dan sifilis kongenital lebih sering pada infeksi baru dengan titer tinggi, dan eritromisin tidak mengobati janin. PNPK 2026 menetapkan regimen penisilin yang lebih ketat khusus untuk ibu hamil.

Sumber: KMK HK.01.07/MENKES/291/2026; Pedoman PPIA Kemenkes 2019

KESELAMATAN TERAPI

Setelah suntikan: apa yang diwaspadai

Reaksi Jarisch-Herxheimer

Demam, nyeri kepala, mialgia < 24 jam. Pada hamil: kontraksi, persalinan preterm, gawat janin. Beri antipiretik; BUKAN alasan menunda terapi.

Anafilaksis

Tanyakan riwayat alergi; siapkan adrenalin; observasi 30 menit setelah injeksi.

Jarak antar dosis

Sifilis laten pada ibu hamil: jarak antar dosis tidak boleh lebih dari 9 hari (tidak hamil: 14 hari). Jadwalkan hari 1, 8, 15 dan pastikan ibu kembali.

Evaluasi janin

USG > 20 minggu: hepatomegali, plasenta tebal, polihidramnion, asites, hidrops; pantau DJJ.

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

05

Bayi, pasangan, dan pemantauan

Mengobati ibu saja belum cukup

Bayi dari ibu dengan sifilis (PNPK 2026)

Kategori	Kriteria	Terapi
Pasti / sangat mungkin	Titer RPR bayi ≥ 4× titer ibu, ATAU pemeriksaan fisik abnormal	Aqueous penisilin G 50.000 IU/kg IV tiap 12 jam (minggu 1), lalu tiap 8 jam, total 10–15 hari; atau prokain 50.000 IU/kg IM/hari
Mungkin	Fisik normal, titer < 4× ibu, tetapi ibu tidak/kurang diobati, terapi < 30 hari sebelum persalinan, atau bukan penisilin	Regimen 10 hari di atas, atau BP 50.000 IU/kg IM dosis tunggal
Kemungkinan kecil	Fisik normal, ibu diobati adekuat ≥ 30 hari sebelum persalinan	BP 50.000 IU/kg IM dosis tunggal
Tidak mungkin	Ibu diobati adekuat sebelum hamil, titer rendah stabil	Tidak perlu terapi; pantau RPR

Sumber: KMK HK.01.07/MENKES/291/2026

Pasangan, pemantauan, dan rujukan

Rujuk bila

- Alergi penisilin (desensitisasi)
- Curiga neurosifilis, sifilis okular atau otosifilis
- Kelainan janin pada USG
- Titer naik ≥ 4× (reinfeksi/gagal terapi)
- Koinfeksi HIV
- Bayi dengan dugaan sifilis kongenital

Di FKTP

1. **Beri BP dosis pertama pada hari diagnosis**
2. Catat titer RPR awal di buku KIA
3. Tes dan obati pasangan sesuai stadium
4. Ulang tes awal trimester III; pantau titer RPR
5. Sampaikan status ibu ke penolong persalinan

Sumber: PNPK Tata Laksana Sifilis 2026

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

06

Promosi dan pencegahan

Triple eliminasi dan target eliminasi sifilis kongenital

Mencegah sifilis kongenital

Triple eliminasi

Permenkes 52/2017: setiap ibu hamil dites HIV, sifilis, dan hepatitis B; tes cepat dual di FKTP

Obati di hari yang sama

Stok benzatin penisilin di FKTP; dosis pertama tanpa menunggu RPR

Pasangan dan keluarga

Notifikasi, tes, dan obati pasangan untuk mencegah reinfeksi

Edukasi dan perilaku

Setia pada pasangan, kondom, kurangi stigma IMS, ANC dini sebelum 16 minggu

Target WHO eliminasi penularan ibu ke anak: sifilis kongenital ≤ 50 per 100.000 kelahiran hidup, dengan ≥ 95% ibu hamil diskrining dan ≥ 95% yang reaktif diobati.

Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2017; WHO 2017

AKTIVITAS

Jawab dengan alur — 5 menit

Kembali ke kasus Ny. S

Stadium?	Sifilis laten: tanpa gejala, tes treponema reaktif, RPR 1:32, waktu tertular tidak diketahui.
Obat?	Benzatin penisilin G 2,4 juta IU IM tiap minggu × 3 (hari 1, 8, 15), jarak tidak lebih dari 9 hari; dosis pertama hari ini.
Waspada?	Reaksi Jarisch-Herxheimer (demam, kontraksi, gawat janin) dan anafilaksis; observasi 30 menit, edukasi tanda bahaya.
Suami & bayi?	Suami dites dan diobati. Bayi dievaluasi saat lahir; bila terapi ibu adekuat ≥ 30 hari sebelum persalinan: BP 50.000 IU/kg dosis tunggal.

KUIS CEPAT

AKTIVITAS · Kahoot / Mentimeter

Uji pemahaman Anda

1. Kapan skrining sifilis pertama dan ulangan pada ibu hamil?
2. Regimen sifilis laten pada ibu hamil menurut PNPK 2026?
3. Mengapa eritromisin tidak cukup untuk ibu hamil?
4. Reaksi apa yang dapat memicu kontraksi setelah injeksi penisilin?
5. Tes mana yang dipakai untuk memantau respons terapi?

Kunci jawaban

1	Kapan skrining sifilis pertama dan ulangan pada ibu hamil?	K1 < 16 minggu; ulang awal trimester III
2	Regimen sifilis laten pada ibu hamil menurut PNPK 2026?	BP 2,4 juta IU IM/minggu × 3, jarak ≤ 9 hari
3	Mengapa eritromisin tidak cukup untuk ibu hamil?	Tidak melewati plasenta; janin tidak terobati
4	Reaksi apa yang dapat memicu kontraksi setelah injeksi penisilin?	Reaksi Jarisch-Herxheimer
5	Tes mana yang dipakai untuk memantau respons terapi?	RPR/VDRL kuantitatif (titer)

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

RINGKASAN

Lima pesan kunci

1. Sifilis kongenital dapat dicegah sepenuhnya dengan skrining dini dan benzatin penisilin
2. Skrining K1 sebelum 16 minggu dengan tes cepat dual HIV/sifilis, ulang awal trimester III
3. Primer/sekunder: BP 2 dosis selang 1 minggu; laten: BP 3 dosis mingguan (jarak ≤ 9 hari)
4. Waspadai reaksi Jarisch-Herxheimer; alergi penisilin dirujuk untuk desensitisasi
5. Obati pasangan, pantau titer RPR, dan evaluasi bayi saat lahir

Daftar pustaka

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/291/2026 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Sifilis. Jakarta: Kemenkes RI; 2 April 2026.

2. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Program Pencegahan Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak. Jakarta: Kemenkes RI; 2019.

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan HIV, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual.

5. World Health Organization. WHO guideline on syphilis screening and treatment for pregnant women. Geneva: WHO; 2017.

6. World Health Organization. WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis). Geneva: WHO; 2016.

7. World Health Organization. Syphilis [fact sheet]. Geneva: WHO; 29 May 2025.

8. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. MMWR Recomm Rep. 2021;70(4):1–187.

9. Kingston M, et al. BASHH UK guidelines for the management of syphilis 2024. Int J STD AIDS. 2024. doi:10.1177/09564624241280406.

10. Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes: sifilis meningkat 70 persen dalam 5 tahun terakhir. Kompas; 8 Mei 2023.

11. Kementerian Kesehatan RI. 23.347 kasus sifilis tercatat sepanjang 2024. CNN Indonesia; 16 Juni 2025.

12. Gomez GB, Kamb ML, Newman LM, et al. Untreated maternal syphilis and adverse outcomes of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ. 2013;91(3):217–26.

13. Cunningham FG, Leveno KJ, Dashe JS, Hoffman BL, Spong CY, Casey BM. Williams Obstetrics. 26th ed. New York: McGraw-Hill; 2022.

14. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care. NICE guideline NG201. London: NICE; 2021.

15. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. Jakarta: KKI; 2019.

Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart
Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalisasi Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi

med.unhas.ac.id